D.胸部 HRCT
98.该患者应采取的主要治疗措施是
A.口服利尿剂
B.静脉应用糖皮质激素
C.吸入支气管舒张剂 COPD:病理不完全可逆
D.口服祛痰药 支气管痉挛是可逆病理改变

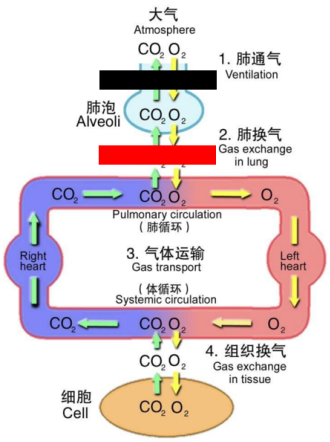
急性加重期

抗生素抗感染
支气管舒张剂
糖皮质激素(住院)
祛痰药
吸氧(鼻导管/机械通气)

3.2016N141-142 B
A.肺泡通气量降低
B.弥散障碍
C.通气/血流比例失调
D.肺内分流
肺栓塞患者出现低氧血症的最主要的机制是
COPD 患者出现低氧血症的最主要的机制是

低氧血症最主要的机制：
①**COPD、支气管哮喘：肺泡通气量下降**
②**特发性肺纤维化：弥散障碍** 呼吸膜增厚
③**肺动脉栓塞、肺炎：V_A/Q 失调** 肺动脉栓塞部分肺泡无血流、肺炎肺泡出现实变(有血无气)
④**肺泡蛋白沉着症、ARDS：肺内分流**（属于 V_A/Q 失调） ARDS:II型肺泡上皮细胞损伤，表面活性物质减少导致肺不张
肺泡蛋白沉着症:基因问题导致表面活性物质清除障碍堆在肺泡内

复习《生理学》V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因：
①动静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差
②CO_2 溶解度比 O_2 大→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→CO_2 扩散比 O_2 快→CO_2 不易潴留
③动脉血 PaO_2 下降和 $PaCO_2$ 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取，因为 CO_2 解离曲线接近线性、而 O_2 解离曲线呈 S 形



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换
若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰 也可以是I型呼衰(完全只是换气障碍)
栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换
若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰 严重时可以变成I/II型呼衰
栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

特发性肺纤维化也属于限制性通气障碍
特征是换气障碍,但一样可以伴有通气障碍

4.2019N73-75 A 男性，45 岁，发作性咳嗽、喘息 10 年，再发 2 天。既往高血压病史 3 年，~~无吸烟~~史。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，~~未闻及~~湿啰音。心率 98 次/分，心律整。胸片检查可见双肺透亮度增加。

看主诉
吸烟10年
和
支气管哮喘一样可以出现湿啰音,只是平时发作的时候,
支气管痉挛太明显了,干啰音基本上掩盖了湿啰音